HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

**«ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ»**

КОНСПЕКТ УРОКА

# Признаки чувствительного пищеварения

## и почему они возникают

## О чём этот урок

Разбираем **причины формирования** чувствительного пищеварения и **что означают его признаки** — «если что-то где-то болит, о чём это говорит».

**Чувствительное пищеварение** — собирательный термин: повышенная реактивность ЖКТ на раздражители (еда, напитки и др.), которые люди со здоровым ЖКТ переносят спокойно.

## 1. Причины формирования чувствительного типа

### Нервная система и стресс

| № | Причина | Что за ней стоит |
|---|---|---|
| 1 | **«Слабый» тип нервной системы** (по классификации академика Павлова) | Повышенная стресс-реактивность, тревожность. Симпатоадреналовая система включается чаще парасимпатической, которая отвечает за пищеварение, отдых и восстановление. Это не «разок понервничал», а глубокий поведенческий паттерн: фоновая тревожность, гиперконтроль, неумение глубоко расслабляться, постоянное внутреннее напряжение, напряжённый живот — почти всегда, кроме сна. Часто формируется в детстве или юности |
| 2 | **Дезадаптация к острому и хроническому стрессу** | Стресс — не объективная реальность, а наша реакция на обстоятельства. Люди с сильным типом нервной системы собираются, действуют и быстро восстанавливаются. При чувствительном типе человек «застревает» в стрессе → истощение, хроническая усталость, нарушения сна, эмоциональная нестабильность, склонность к депрессии. Это дополнительно разрегулирует нервную систему, управляющую ЖКТ |
| 3 | **Ослабление защитных факторов слизистой ЖКТ** | Следствие пунктов 1 и 2 на уровне тела: изменения нервной и гормональной регуляции ЖКТ из-за нарушений сна, хаоса в питании, ненормированного графика, нехватки и плохого усвоения белка и жиров. Слизистая становится гиперчувствительной и гиперреактивной |

Напряжённый живот со временем формирует **висцеральную гиперчувствительность**: ЖКТ начинает чрезмерно реагировать на всё. В тяжёлых случаях возможны невротические отношения с едой и психогенные расстройства (булимия, анорексия) — это отдельная тема; на программе мы говорим о чувствительном пищеварении с физиологической точки зрения.

## Питание и другие факторы

| № | Причина | Пояснение |
|---|---|---|
| 4 | **Нерегулярное питание** | Еда на бегу, нет чётких завтрака, обеда, ужина; длинные перерывы и частые перекусы. Человек долго терпит голод, увлёкшись делами, а потом «готов съесть коня в шерсти» и набрасывается на еду |
| 5 | **Избыток грубой клетчатки** | Сыроедение, вегетарианство, веганство: много сырых и приготовленных овощей, бобовых, круп — тяжело для ЖКТ |
| 6 | **Строгие диеты → дефициты** | Витамины группы B (особенно B1), магний, железо, цинк — участвуют в работе пищеварительных ферментов, моторике, восстановлении слизистых. Гарантированы при строгих диетах, несбалансированном вегетарианстве и веганстве |
| 7 | **Неправильное голодание** | Люди с чувствительным пищеварением любят эксперименты над собой, в том числе голодание. Неправильное голодание усугубляет состояние и становится триггером обострений |
| 8 | **Врождённые и приобретённые ферментопатии** | Целиакия, непереносимость молочного, фруктозы; приобретённая — нецелиакийная чувствительность к глютену: в детстве её нет, а к середине жизни глютен начинает плохо переноситься |
| 9 | **Нарушения микробиоты** | Вследствие диет, ферментопатий, инфекций, приёма лекарств — утяжеляют признаки |
| 10 | **Конституция с преобладанием доши Ветер / Вата** | Для интересующихся восточной медициной: описанные признаки характерны для избытка Ваты и сами её усиливают |

**Как правило, работает совокупность факторов:** «слабый» тип нервной системы + хронический стресс + питание кое-как и мало внимания ко сну + перенесённая инфекция — и стартует, например, синдром раздражённого кишечника.

**Задание.** Подумайте, какая совокупность факторов в питании и образе жизни сформировала чувствительное пищеварение у вас. Напишите в комментариях к уроку.

## 2. Что означают ваши жалобы

### 2.1. Язык

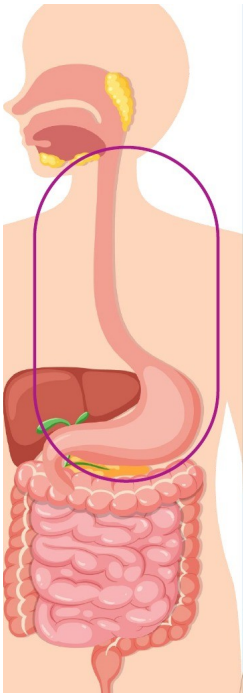


*Трещины на языке; «географический» язык — участки с налётом и без*

**Трещины, чувствительный язык, «географический» язык**

**Что происходит:** язык ярко реагирует на кислое, жгучее, горячее, холодное; «географический» — участки с налётом чередуются с участками без налёта. Это говорит о **дефиците витаминов B9 и B12**, которые участвуют в регенерации слизистых и восстановлении клеток, а также о **нарушении микробиома** ЖКТ и полости рта.

## 2.2. Пищевод и желудок



### Изжога, жжение в пищеводе

**Что происходит:** при чувствительном типе обычно нет воспаления — есть чрезмерная чувствительность. **Гиперчувствительный пищевод и функциональная изжога** — аномальная реакция нервных рецепторов на физиологические рефлюксы. Даже у здоровых людей бывает до 50 небольших забросов в день, но их не ощущают; при гиперчувствительности их чувствуют как изжогу и жжение. Повреждений слизистой при этом нет.

**Возможные диагнозы:** гиперчувствительный пищевод, функциональная изжога; ГЭРБ — снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера («зияние») и свободный заброс содержимого желудка в пищевод; грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД).

**Как проверить:** состояние слизистой пищевода и ГЭРБ оценивают по ФГДС; ГПОД по ФГДС не увидеть — нужен рентген. ГЭРБ посвящён отдельный урок курса.

### Чувствительность к температуре пищи (неприятно глотать холодное или горячее)

**Что происходит:** ослаблены защитные факторы слизистой ЖКТ — слизистая гиперчувствительна.

**Отрыжка**

**Что происходит:** несмыкание нижнего пищеводного сфинктера; замедленная эвакуация пищи из желудка — нарушены моторика и секреция (мало соков, ферментов, соляной кислоты), желудок медленно растягивается и сокращается, пища задерживается. Часто соседствует с пониженной кислотностью.

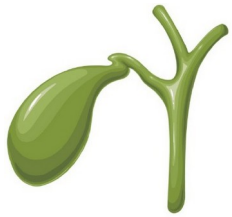
**Возможные диагнозы:** ГЭРБ.

**Слабые тянущие или ноющие боли в животе — натощак или после еды**

**Что происходит:** нервные рецепторы желудка чрезмерно реагируют на растяжение и сокращение мышц, на желудочный сок — кислоту и ферменты. Признак пересекается с вялым пищеварением.

**Возможные диагнозы:** функциональная диспепсия с гиперчувствительностью.

## 2.3. Правое подреберье — желчный пузырь и протоки





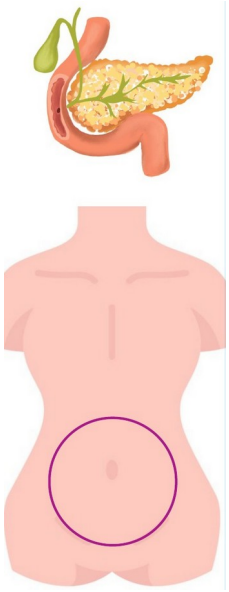
**Дискомфорт или слабые боли в правом подреберье**

**Что происходит:** правое подреберье — зона чуть ниже рёбер справа, где расположены жёлчный пузырь и протоки. Боли не острые, а на грани дискомфорта — **нарушение оттока желчи**. «Фирменный» диагноз чувствительного пищеварения — дискинезия желчевыводящих путей, гипомоторная или гипермоторная. Боль возникает либо из-за гиперчувствительности к сокращениям протоков, либо из-за переполнения и растяжения стенок пузыря.

**Возможные диагнозы:** дискинезия желчевыводящих путей; сладж (застой желчи) в пузыре; хронический холецистит без камней.

**Риск:** при гипомоторной дискинезии — формирование камней жёлчного пузыря.

## 2.4. Область вокруг пупка — тонкая кишка

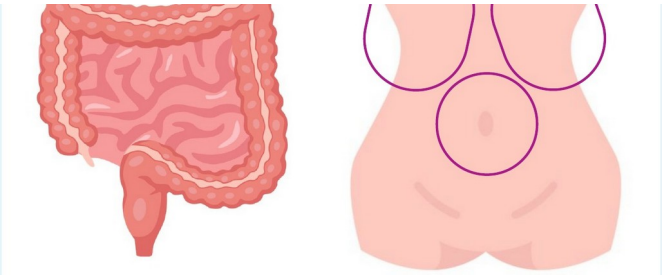


**Вздутие вскоре после еды (через 30–60 минут), особенно на смешанную пищу, обильную трапезу, прохладные напитки**

**Что происходит:** признак больше вялого типа, но частый при смешанном «вялое + чувствительное». Через 30–40 минут пища начинает поступать в 12-перстную кишку — основное место переваривания, куда открываются протоки жёлчного и поджелудочной и где выделяются кишечные ферменты. Если чего-то не хватает — начинается вздутие.

**Возможные диагнозы:** нарушение желчеоттока; снижение функции поджелудочной железы; кишечные ферментопатии (например, не хватает ферментов для глютена или молочного).

## 2.5. Толстая кишка



**Регулярное вздутие во второй половине дня — «визитная карточка» чувствительного типа**

**Что происходит:** к этому времени пища, съеденная утром и в обед, доходит до толстой кишки, где клетчатку перерабатывает микробиота и формируются каловые массы. При гиперчувствительности кишечника (аномальная реакция на растяжение стенок клетчаткой), нарушении моторики или микробиома клетчатка обрабатывается плохо — живот как «беременный».

**Возможные диагнозы:** синдром раздражённого кишечника (СРК), дисбиоз.

**Диарея, несформированный стул, слизь в стуле, ощущение неполного опорожнения**

**Что происходит:** может быть причиной СРК; либо проблемы на этапе тонкой кишки — недостаток ферментов тонкой кишки и поджелудочной, нарушение желчеоттока. Признак необязательный: с тем же успехом бывают запоры.

**Возможные диагнозы:** СРК.

## Запоры: атонический и спастический

Для чувствительного типа характерны в основном **спастические** запоры, но бывает и смешанный тип. Утром, лёжа в постели, прощупайте зону толстой кишки справа и слева:

**Атонический запор**

✔️ слабая моторика восходящей ободочной кишки — правый бок

✔️ справа ощущается «что-то лишнее», кишечник напряжённый

✔️ стул редкий — раз в 2–3 дня, иногда раз в неделю; обильный, сформированный

**Спастический запор**

✔️ нарушение моторики нисходящей ободочной и сигмовидной кишки — левый бок

✔️ справа ничего не беспокоит, а левый бок спазмирован, болезнен, что-то перекатывается под пальцами

✔️ стул примерно через день-два, сухой, мелкими катышками («козий»)

**Что означает:** нарушение моторики кишечника, возможно — нарушение микробиома.

**Газообразование от клетчатки (зелень, салаты, капуста, яблоки, фрукты со шкуркой)**

**Что происходит:** возможен просто избыток грубой клетчатки — чувствительный кишечник не справляется с объёмом. **Что делать:** сначала снизить количество грубой клетчатки, затем постепенно увеличивать, приучая ЖКТ. Другие причины — нехватка ферментов для расщепления клетчатки, дисбиоз (бактерии не справляются с её обработкой), гиперчувствительность кишечника.

## 3. Шпаргалка: жалоба → что за ней стоит

| Жалоба | Что означает |
|---|---|
| Трещины, «географический», чувствительный язык | Дефицит B9, B12; нарушение микробиома ЖКТ и полости рта |
| Изжога, жжение в пищеводе | Гиперчувствительный пищевод, функциональная изжога, ГЭРБ, ГПОД |
| Чувствительность к температуре пищи | Ослабление защитных факторов слизистой |
| Отрыжка | Несмыкание нижнего пищеводного сфинктера, ГЭРБ, медленная эвакуация из желудка |
| Слабые ноющие боли в животе | Функциональная диспепсия с гиперчувствительностью |
| Дискомфорт в правом подреберье | Дискинезия ЖВП, сладж, холецистит без камней; риск камней |
| Вздутие через 30–60 минут после еды | Нехватка желчи, ферментов поджелудочной и кишечника |
| Вздутие во второй половине дня | СРК, дисбиоз, гиперчувствительность кишечника |
| Диарея, слизь, неполное опорожнение | СРК; нехватка ферментов, нарушение желчеоттока |
| Запор (чаще спастический) | Нарушение моторики кишечника и микробиома |

| Жалоба | Что означает |
|---|---|
| Газы от клетчатки | Избыток грубой клетчатки, нехватка ферментов, дисбиоз |

## Вопросы для самопроверки

1. Что такое чувствительное пищеварение?
2. Что такое «слабый» тип нервной системы по Павлову и как он влияет на ЖКТ?
3. Что значит дезадаптация к стрессу и чем она отличается от реакции людей с сильным типом нервной системы?
4. Как стресс и образ жизни ослабляют защитные факторы слизистой ЖКТ?
5. Какие особенности питания формируют чувствительное пищеварение?
6. Почему избыток грубой клетчатки и строгие диеты вредны при чувствительном типе?
7. Что такое нецелиакийная чувствительность к глютену?
8. О чём говорят трещины на языке и «географический» язык?
9. Чем гиперчувствительный пищевод и функциональная изжога отличаются от ГЭРБ? Сколько рефлюксов в день бывает в норме?
10. Как проверить, есть ли ГЭРБ или грыжа пищеводного отверстия диафрагмы?
11. О чём говорят чувствительность к температуре пищи и частая отрыжка?
12. Почему возникают слабые боли в правом подреберье и какой диагноз называют «фирменным» для чувствительного типа?
13. Почему вздутие возникает через 30–60 минут после еды?
14. Почему вздутие во второй половине дня называют «визитной карточкой» чувствительного пищеварения?
15. Как отличить атонический запор от спастического? Какой характерен для чувствительного типа?
16. Что делать при газообразовании от клетчатки?